BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemograma Completo
Material:
Sangue
Método:
Analisador Automatizado (Contagem por impedância e análise celular por citometria de fluxo)
SÉRIE VERMELHA
Valores de referência
Hemácias
4,440
milhões/mm3
4,5 a 5,9 milhões/mm3
Hemoglobina
12,60
g/dL
13,5 a 17,5 g/dL
Hematócrito
38,30
%
41,0 a 53,0 %
V.C.M.
86,26
fL
80,0 a 98,0 fL
H.C.M.
28,38
pg
27,0 a 32,0 pg
C.H.C.M.
32,90
g/dL
31,0 a 35,0 g/dL
R.D.W. (CV)
17,20
%
11,5 a 14,5 %
R.D.W. (SD)
53,40
fL
38,6 a 49,1 fL
Observações
Anisocitose (++)
SÉRIE BRANCA
LEUCÓCITOS
7,29
milhares/mm3
5,0 a 10,0 milhares/mm3
(%)
milhares/mm3
Blastos
0,00
0,0
Ausentes

Pro-mielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Mielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Metamielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Neutrófilos Bastonetes
3,00
0,22
0 a 3 % (Até 830/mm3)
Neutrófilos Segmentados
59,80
4,36
35 a 75 % (1.520 a 4.980/mm3)
Eosinófilos
0,80
0,06
0 a 3 % (30 a 400/mm3)
Basófilos
0,70
0,05
0 a 1 % (Até 80/mm3)
Linfócitos típicos
26,90
1,96
20 a 50 % (900 a 3.400/mm3)
Linfócitos atípicos
0,00
0,00
Ausentes
Monócitos
8,80
0,64
2 a 10 % (240 a 680/mm3)
Células Indiferenciadas
0,00
0,00
Ausentes
Razão Neutrófilos/Linfócitos (NLR)
2,33
1,00 a 3,00
PLAQUETAS
198,0
milhares/mm3
140 a 400 milhares/mm3
M.P.V.
11,40
fL
7,5 a 11,5 fL
Legenda (Alterações/Graduação): (+) Discreta (5-25%); (++) Moderada (25-50%); (+++) Acentuada (>50%).
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09

Data/Hora Liberação:

24/08/2024 - 17:17:28

*Análise realizada por equipamentos Sysmex Série-XN. Padronizações de nomenclatura e graduação de alterações reportadas conforme: ICSH

Recomendations for the standardization of nomenclature and grading of peripheral blood cell morphological features - PALMER L. et al.

Int. Jnl. Lab. Hem. 2015, 37, 287-303. (Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25728865/)

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Ferritina Sérica.....:
8,4
ng/mL
Material :
Sangue
Método :
Quimioluminescência (CLIA)
V.R.:
Critérios para definição de Deficiência de Ferro (ASH/2026):
1) Crianças de 9 meses a 4 anos: Deficiência se Ferritina < 20,0 ng/mL
2) Adultos em geral: Deficiência se Ferritina < 30,0 ng/mL
3) Presença de sintomas ou condições específicas: Gestantes, fadiga crônica, queda de cabelo,
menstruação excessiva, síndrome das pernas inquietas: Deficiência se Ferritina < 50 ng/mL.
4) Presença de Inflamação (Proteína C Reativa ou VHS elevados), Câncer ou Doença Infecciosa:
Deficiência se Ferritina < 100,0 ng/mL ou se Índice de Saturação da Transferrina < 20%.
Referência: Blood Adv. 2026 Aug 24:bloodadvances.2025015950. doi: 10.1182/bloodadvances.2025015950.
American Society of Hematology 2026 guidelines for diagnosis of iron deficiency. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42747316/.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 01:34:32
Ácido Fólico (Vitamina B9):
16,8
ng/mL
Material :
Sangue
Método :
Quimioluminescência (CLIA)
V.R.:
3,4 a 19,6 ng/mL
IMPORTANTE: O uso de suplementos e/ou medicamentos contendo Biotina (Vitamina B7), sobretudo em doses acima das necessidades básicas diárias (30 mcg/dia), pode causar alterações significativas em resultados de
exames realizados por imunoensaios, devido à interferência no sistema Streptavidina/Biotina utilizado nos ensaios imunométricos. Por este motivo é recomendada a suspensão do uso de qualquer medicamento ou
suplemento, contendo Biotina, 72 horas antes da coleta da amostra para a realização dos exames, ou a REPETIÇÃO dos exames de pacientes que apresentarem resultados alterados, sem presença de sintomas ou outras
alterações clínicas, em um período de no mínimo 72 horas após a suspensão do uso de medicamentos e/ou suplementos que contenham BIOTINA (Vitamina B7). Referências: 1) Wijeratne NG, Doery JC, Lu ZX. Positive
and negative interference in immunoassays following biotin ingestion: a pharmacokinetic study. Pathology 2012;44:674-5. 2) https://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm586505.htm
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 00:16:15
09/08/22
16:05:19
23/08/24
13:47:09
0

100
200
300
400
22,7 8,4

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Ferro .....:
38
ug/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico
V.R.:
49 - 181 ug/dL
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 17:17:28
Capacidade de Fixação do Ferro e Saturação da Transferrina
Material :
Sangue
Metodo :
Colorimétrico - Ferrozine® (Goodwin modificado)
Capacidade Total de Ligação do Ferro (TIBC):
373
µg/dL
VR:
250 a 410 µg/dL
Capacidade Livre de Ligação do Ferro:
335
µg/dL
VR:
140 a 280 µg/dL
Índice de Saturação da Transferrina.....:
10,19
%
VR:
20 a 50 %
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberacao:
24/08/2024 - 17:17:28

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Glicemia de Jejum .....:
69
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico Enzimático (Glicose-Oxidase)
V.R.:
Normal .....: 65 a 99 mg/dL
Pré-Diabetes .....: 100 a 125 mg/dL
Diabetes .....: Igual ou superior a 126 mg/dL
Fonte: SBD 2024 (https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/)
Gestantes:
Normal .....: Inferior a 92 mg/dL
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) .....: De 92 a 125 mg/dL
Diabetes Mellitus diagnosticado na gestação .....: Igual ou superior a 126 mg/dL
Fonte: SBD 2024 (https://diretriz.diabetes.org.br/rastreamento-e-diagnostico-da-hiperglicemia-na-gestacao/)
Obs. 1: DEVE SER CONSIDERADO estabelecer o diagnóstico de DM na presença de glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL e HbA1c igual ou superior a 6,5% em uma mesma amostra de sangue.
Obs. 2: Com o intuito de não postergar o início de tratamento em situações agudas, o diagnóstico de DM poderá ser feito por meio de glicemia "ao acaso" (fora do estado metabólico de jejum) com valor igual ou superior a 200 mg/dL, quando na presença de sintomas inequívocos de hiperglicemia.
Fonte: Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2024) https://diretriz.diabetes.org.br/
IMPORTANTE:
Estes Valores de Referência NÃO SE APLICAM para "Glicemia ao acaso" (SEM CUMPRIR JEJUM de 8 a 12h).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 00:04:08
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
50
100
150
200
138
73 69

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Creatinina com eTFG
Material :
Sangue
Metódo :
Colorimétrico Automatizado (Picrato/Jaffé)
Resultado .....:
1,78
mg/dL
VR:
Masculino (> 12 anos): 0,7 a 1,3 mg/dL
Importante: Atentar para elevação dos valores de Creatinina em pessoas que estejam realizando uso de suplementação de Creatina. Esta elevação pode ser
suficiente para falsear os valores de eTFG, induzindo à suspeita de perda de função renal artificialmente. Ref.: DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21867
Taxa de Filtração Glomerular Estimada p/ 1,73 m²(eTFG):
42,6
mL/min
Método :
Equação CKD-EPI eGFRcr 2021
A eTFG relatada é baseada na equação
CKD-EPI 2021
que não usa coeficiente racial. Os valores da eTFG, baseados na equação
eGFRcr CKD-EPI 2021
, precisam ser
interpretados com base no contexto clínico. As recomendações da prática clínica sugerem solicitar cistatina C como teste confirmatório para pacientes com eTFG de 45-59
mL/min/1,73m2 com RAC < 30 mg/g, e em pacientes para os quais a creatinina pode ser um indicador menos confiável de eTFG próximo à decisão pontos. Situações em que
fatores não relacionados à TFG podem ter um grande efeito na creatinina sérica incluem alterações na geração de creatinina (doenças de perda muscular, amputados,
fisiculturistas, dieta vegana, suplementação com Creatina), medicamentos que afetam a secreção tubular de creatinina (cimetidina, cobicistate, dolutegravir, fenofibrato, ritonovir,
trimetoprim e outros) e condições com eliminação extra-renal de creatinina (perdas gastrointestinais e do “terceiro espaço”).
Ref.:
https://www.kidney.org/content/national-kidney-
foundation-laboratory-engagement-working-group-recommendations-implementing ;
https://arquivos.sbn.org.br/pdf/biomarcadores.pdf ; https://www.rbac.org.br/artigos/taxa-de-
filtracao-glomerular-estimada-em-adultos/
Critérios para DRC: Qualquer uma das seguintes condições, PRESENTES POR MAIS DE 3 MESES: Albuminúria/Creatininúria: (RAC ≥ 30 mg/g) ; Anormalidades no sedimento
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0,5
1
1,5
2
2,5
1,23

1,60 1,78
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
50
100
150
200
250
48,7 42,6

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

urinário ; Eletrólitos e outras anormalidades devido a distúrbios tubulares ; Anormalidades detectadas por histologia ; Anormalidades estruturais detectadas por imagem ; História

do transplante renal ; TFG reduzida TFG <60 ml/min/1,73 m2. Abreviaturas:

DRC

(Doença Renal Crônica);

TFG

(Taxa de Filtração Glomerular). Fonte:

https://www.kidney.org/professionals/explore-your-knowledge/what-is-the-criteria-for-ckd.

Data/Hora Coleta:

23/08/2024 - 13:47:09

Data/Hora Liberação:

24/08/2024 - 17:17:28

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Ureia / Nitrogênio Ureico (BUN)
Material :
Sangue
Metodo :
Cinética UV - Urease
Nitrogênio Ureico (BUN)..:
21,5
mg/dL
VR:
9 a 20 mg/dL
Ureia.....:
46,0
mg/dL
VR:
Ureia em Adultos (Masculino): 19 a 50 mg/dL
Nitrogênio Ureico em Adultos (Masculino): 9 a 23 mg/dL
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberacao:
24/08/2024 - 00:06:09
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
10
20
30
40
20,6
25,2 21,5
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
10
20
30
40
50
60
70
44,0
54,0 46,0

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Microalbuminúria (Urina aleatória) - RAC
Material :
Urina simples
Metodo :
Imunoturbidimetria
Albumina urinária.....:
3,30
µg/mL
VR:
Comumente são tolerados valores inferiores a 30,0 µg/mL na urina aleatória ("spot").
Creatinina urinária.....:
120,0
mg/dL
VR:
63,0 a 250,0 mg/dL
Relação Albumina/Creatinina (RAC):
2,8
mg/g Creat
VR:
Ideal (Normoalbuminúria): Inferior a 30 mg/g de creatinina
Alteração moderada (Microalbuminúria): 30 a 299 mg/g de creatinina
Albuminúria Clínica (Macroalbuminúria): Superior ou igual a 300 mg/g de creatinina
É necessário considerar que o valor de 30 ug/mg de RAC pode não ser adequado para pacientes de todas as idades, sexo e etnias, e ter em mente que a relação entre
a excreção de albumina na urina e o aumento do risco cardiovascular ou renal é contínuo, sendo inadequado considerar todos os valores de RAC abaixo de 30 ug/mg
como normais, por este motivo.
Importante:
Existem fatores pré-analíticos que afetam a excreção de albumina na urina e alguns cuidados devem ser tomados:
Exercício
físico intenso:
Aumenta a excreção de albumina na urina (Não deve ser realizado o exame após exercício físico intenso (24 a 48h).
Febre:
Aumenta a excreção de
albumina na urina (Não deve ser realizado o exame até 3 dias após febre).
Referência:
MILLER, W. G. et al.; on behalf of the National Kidney Disease Education
Program – IFCC Working Group on Standardization of Albumin in Urine.
Fonte: https://www.bjid.org.br/en-terapia-antirretroviral-e-funcao-renal-articulo-X217751171655969X
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberacao:
23/08/2024 - 17:55:28

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Cálcio Sérico Total (CaT) .....:
9,2
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Arsenazo III - Colorimetrico
V.R.:
8,4 a 10,2 mg/dL
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 00:06:09

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

25 - Hidroxi - Vitamina D (25(OH)D):
19,6
ng/mL
Material :
Sangue
Metodo :
Quimioluminescência (Abbott)
Fonte:
Maeda SS, Borba VZ, Camargo MB, Silva DM, Borges JL, Bandeira F, et al.
Recommendations of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabology (SBEM) for the diagnosis and
treatment of hypovitaminosis D
. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 2014;58(5):411-33.
https://www.endocrino.org.br/vitamina-d-novos-valores-de-referencia/
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 17:17:28
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
50
100
150
21,3 19,6

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Vitamina B12 (Cobalamina):
444,0
pg/mL
Material :
Sangue
Metodo :
Quimioluminescência (CLIA)
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 00:13:10
09/08/22
16:05:19
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
200
400
600
800
1.000
1.200
288,0
443,0 444,0

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Colesterol Total...:
113
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Enzimático-colorimétrico - CHOD-PAP
V.R.:
| Com jejum | Sem jejum | Categoria referencial |
| < 190 mg/dL | < 190 mg/dL | Desejável |
Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq
Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Valores de Colesterol Total ≥ 310 mg/dL (para adultos) ou ≥ 230 mg/dL (crianças e adolescentes) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas
as dislipidemias secundárias.
A HF é a mais comum entre as dislipidemias e seus portadores tem 20 vezes mais risco de morte precoce por Doença Cardiovascular.
Fonte
:
Sociedade Brasileira de Cardiologia -
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose;
Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 01:34:32
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
50
100
150
200
250
300
112
154 113

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Determinação de Colesterol-HDL e Não-HDL
Material:
Sangue
Metodo:
Enzimático Colorimétrico
Colesterol - HDL.....:
43
mg/dL
VR:
| Com jejum | Sem jejum | Categoria referencial |
Adultos (> 20 anos)| > 40 mg/dL | > 40 mg/dL | Desejável |
(De 0 a 19 anos)| > 45 mg/dL | > 45 mg/dL | Desejável |
Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Colesterol Não-HDL...:
70
mg/dL
VR:
| Metas Desejáveis por Categoria de Risco Cardiovascular Pré-Estabelecido |
Categoria de Risco	Com jejum	Sem Jejum
Baixo	< 145 mg/dL	< 145 mg/dL
Intermediário	< 130 mg/dL	< 130 mg/dL
Alto	< 100 mg/dL	< 100 mg/dL
Muito Alto	< 80 mg/dL	< 80 mg/dL
Extremo	< 70 mg/dL	< 70 mg/dL
Obs.: Os valores de referência para "Colesterol Não-HDL" foram estabelecidos como METAS desejáveis, estratificadas de acordo com o risco cardiovascular calculado de cada pessoa, com base em histórico e comorbidades. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
20
40
60
80
100
27
36 43
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
50
100
150

200
85
118 70

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Quanto maior o RISCO CARDIOVASCULAR que o paciente possui, mais exigente são as METAS que o paciente deverá manter de Colesterol Não-HDL (mais baixos). Portanto, o Risco é previamente determinado por diversos fatores como idade, histórico, obesidade, genética, comorbidades e comportamento. A partir desta avaliação do RISCO os valores de METAS devem ser alcançados visando a PREVENÇÃO de eventos cardiovasculares.
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberacao:
24/08/2024 - 01:34:32

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 15 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Colesterol - LDL .....:
55
mg/dL
Material :
Sangue
Metodo :
Conforme descrito por Martin et al., 2013
Anteriores:
Os valores de referência para "Colesterol-LDL" foram estabelecidos como METAS desejáveis, estratificadas por nível de exigência (conforme demonstrado abaixo) de acordo com o risco cardiovascular de cada paciente previamente calculado, com base em histórico e comorbidades. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Note que quanto maior o RISCO CARDIOVASCULAR que o paciente possui, mais EXIGENTE (ou seja, mais BAIXO) é o valor de LDL-Colesterol que o paciente DEVERÁ MANTER, visando a prevenção de doenças cardiovasculares.
Para pacientes com Triglicerídeos > 800 mg/dL recomenda-se utilizar as metas de Não-HDL Colesterol ao invés das metas de LDL.
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 01:34:31

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 16 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Triglicerídeos .....:
71
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico enzimático - Oxidase/Peroxidase
V.R.:
Crianças: 0 a 9 anos | 10 a 19 anos | Acima de 20 anos |
Com Jejum 12h: Inferior a 75 mg/dL | Inferior a 90 mg/dL | Inferior a 150 mg/dL |
Sem Jejum 12h: Inferior a 85 mg/dL | Inferior a 100 mg/dL | Inferior a 175 mg/dL |
Importante: Se a concentração de Triglicerídeos estiver > 440 mg/dL sem cumprimento de jejum
prolongado (12h), deve ser realizada outra avaliação com o cumprimento do jejum de 12 horas. Obs:
Para pacientes com resultado de Triglicerídeos > 800 mg/dL utilizar os valores de Não-HDL Colesterol
como METAS ao invés dos valores de LDL. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da
Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Importante: Se a concentração de Triglicerídeos estiver > 440 mg/dL sem cumprimento de jejum prolongado (12h), deve ser realizada outra avaliação com o cumprimento do jejum de 12 horas.
"A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e a estratificação do risco para estabelecimento das metas
terapêuticas". Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (versão 1.13).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 00:05:08
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
50
100
150
200
250
150 104 71

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 17 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TSH Ultrassensível (Hormônio Tireoestimulante):
1,01
µUI/mL
Material :
Sangue
Método :
Quimioluminescência (Siemens Heathcare Diagnostic)
V.R.:
Sangue do cordão.....: 1,30 a 20,00 µUI/mL
1 a 6 dias .....: 1,30 a 17,00 µUI/mL
1 a 10 semanas.....: 0,60 a 10,00 µUI/mL
11 semanas a 1 ano.....: 0,40 a 7,00 µUI/mL
1 a 5 anos.....: 0,40 a 6,00 µUI/mL
Acima de 5 anos e adultos...: 0,34 a 5,60 µUI/mL
Gestantes:
1º Trimestre.....: 0,10 a 2,50 µUI/mL
2º Trimestre.....: 0,20 a 3,00 µUI/mL
3º Trimestre.....: 0,30 a 3,00 µUI/mL
Valores propostos pela ATA (American Thyroid Association): ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6358369/
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
24/08/2024 - 00:11:10
22/01/24
15:20:31
23/08/24
13:47:09
0
2
4
6
8
1,43 1,01

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-08-23 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 18 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Urina Tipo I - Elementos Anormais e Microscopia (EAS)
Material:
Urina Jato Médio
Método:
Análise Química (Tira) / Reflectância Automatizada / Citometria de Fluxo / Microscopia (Óptica e/ou Digital).
Resultados:
Valores de Referência:
Caracteres gerais:
Aspecto
Límpido
Límpido
Cor
Amarelo Claro
Amarelo claro a Amarelo
Densidade
1,016
1,015 a 1,025
pH
5,5
5,0 a 7,5
Elementos anormais:
Relação Albumina/Creatinina (RAC)
0
mgAlb/gCr
Inferior a 30 mgAlb/gCr
Proteínas
0
mg/dL
0 mg/dL
Glicose
100
mg/dL
0 mg/dL
Corpos Cetônicos
0
mg/dL
0 mg/dL
Bilirrubinas
0
mg/dL
0 mg/dL
Urobilinogênio
1,4
mg/dL
Inferior a 2,0 mg/dL
Nitrito
Negativo
Não Reagente
Sangue (Hb)
0,01
mg/dL
Inferior a 0,03 mg/dL

Esterase (Leucócitos Granulócitos)
Ausência
Ausência (LD ~ 5 leu/uL)
Análise Microscópica (Óptica/Digital):
Hemácias
3
/uL
Inferior a 10/uL
Leucócitos
1
/uL
Inferior a 20/uL
Células Epiteliais Escamosas
0
/uL
Inferior a 25/uL
Células Epiteliais Não Escamosas
1
/uL
Inferior a 10/uL
Leveduras
Ausente
Ausente
Bacteriúria
Ausente
Ausente
Filamentos de Muco
Ausente
Ausente
Cristais
Ausente
Ausente
Cilindros
Ausente
Ausente
Obs.1: Pacientes em uso de inibidores da SGLT2 (reabsorção tubular de glicose) ex: Dapagliflozina, empaglifozina, canagliflozina e ertugliflozina) apresentam glicosúria mesmo com glicemia normal.
Obs.2: Presença de agentes redutores como ácido ascórbico pode levar a resultados falsos-negativos para hemoglobinúria. A presença de Mioglobina, medicamentos contendo grupo SH (ex: Glutationa,
bucilamina) e agentes oxidantes (Hipoclorito de sódio, ácido hipocloroso) pode gerar resultados falsos-positivos para hemoglobinúria. Obs.3: RAC até 30 mgAlb/gCr = Normal; Entre 30 e 300 mgAlb/gCr =
Microalbuminúria; Valores >= 300 mgAlb/gCr = Macroalbuminúria. Os valores de RAC devem ser interpretados com cautela, como triagem, sendo os valores < 30 mgAlb/gCr considerados negativos com
probabilidade de 99%. Obs.4: Na presença de Cefalexina ou gentamicina o resultado da esterase por apresentar-se falso-negativo. Presença de grande quantidade de ácido ascórbico (> 100 mg/dL) pode
causar resultado falso-negativo para Nitrito e Bilirrubina. Obs.5: Hemácias, leucócitos e células epiteliais expressos por uL, para uma correlação aproximada com a contagem "p/ campo" dividir o valor por
5,04 (Conforme preconizado pela norma ABNT NBR 15268:2025). Bacteriúria ausente: < 58/uL; Raras: 59 a 1500/uL; Moderada: 1500 a 4500/uL; Aumentada: > 4500/uL. Novos valores de referência para
hematúria e piúria a partir de 29/01/2024.
Data/Hora Coleta:
23/08/2024 - 13:47:09
Data/Hora Liberação:
23/08/2024 - 14:51:53